UE B2 · SEMESTRE 1

Psychopathologie — Flashcards

Formulez votre réponse avant de lire la réponse et les précisions de chaque carte.

350 cartes | Classées par thème

Champ, normalité et causalité

CARTE 001

Comment définir la psychopathologie et quels sont ses repères généraux ?

> Réponse. Discipline qui étudie les troubles et la souffrance psychiques.

À comprendre. Son objet est la souffrance psychique, sa méthode clinique ou expérimentale, et son champ est proche de celui de la psychiatrie, avec un accent sur la connaissance et la compréhension.

CARTE 002

Comment les auteurs Piéron, Pedinielli, Ménéchal et Samacher définissent-ils le champ de la psychopathologie ?

> Réponse. Piéron en souligne la description, la classification, les mécanismes et l'évolution. Pedinielli la situe comme une sous-discipline de la psychologie ayant pour objet l'évaluation, le diagnostic, l'aide et le traitement de la souffrance psychique, quelle que soit son origine. Ménéchal la présente comme la science de la souffrance psychique ; Samacher étend sa définition à l'étude des maladies mentales, du fonctionnement mental anormal et des conduites pathologiques.

CARTE 003

Comment définir « Souffrance psychique » ?

> Réponse. Expérience pénible concernant la vie mentale et affective.

À comprendre. Elle peut être exprimée par la personne ou repérée par son entourage, et s'apprécie avec son intensité, sa durée, son contexte et son retentissement.

CARTE 004

Comment définir « Psychologie clinique » ?

> Réponse. Démarche de compréhension et d'étude du sujet dans sa singularité et dans sa situation.

À comprendre. Son champ ne se limite pas aux maladies mentales.

CARTE 005

Comment définir « Psychiatrie » ?

> Réponse. Discipline médicale qui prend en charge les troubles psychiques, avec des dimensions diagnostiques, thérapeutiques, préventives et de réadaptation.

CARTE 006

Comment définir « Normalité » ?

> Réponse. Repère relatif à des normes individuelles, sociales et culturelles.

À comprendre. Elle ne se confond ni avec la fréquence statistique d'un comportement ni avec l'absence de toute souffrance.

CARTE 007

Comment définir « Pathologique » ?

> Réponse. Ce qui relève d'un trouble ou d'un processus morbide, apprécié à partir d'un ensemble de manifestations, du vécu, du contexte et du retentissement ; aucun critère isolé ne suffit systématiquement.

CARTE 008

Comment définir « Pathologisation du normal » ?

> Réponse. Attribution injustifiée d'un caractère maladif à une variation ordinaire, comme assimiler toute tristesse à une dépression.

CARTE 009

Comment définir « Normalisation du pathologique » ?

> Réponse. Banalisation d'une manifestation préoccupante, dont la souffrance ou le danger mérite pourtant une évaluation.

CARTE 010

Comment définir « Déviance sociale » ?

> Réponse. Écart à une norme sociale ou individuelle.

À comprendre. Sa signification dépend du contexte historique et culturel ; elle ne constitue pas en soi un diagnostic.

CARTE 011

Comment définir « Handicap et limitation » ?

> Réponse. Limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

À comprendre. Le support l'utilise comme repère de retentissement, à replacer dans l'environnement réel.

CARTE 012

Comment définir « Contact avec la réalité » ?

> Réponse. Capacité à situer ses perceptions, pensées et expériences par rapport au monde partagé, en tenant compte du contexte culturel et de l'adaptation concrète.

CARTE 013

Comment définir « Comportement désadapté » ?

> Réponse. Conduite qui ne permet pas de répondre de façon adéquate à la situation ou entraîne des difficultés de fonctionnement.

À comprendre. Son appréciation nécessite le contexte.

CARTE 014

Comment définir « Anosognosie » ?

> Réponse. Méconnaissance par la personne de l'existence de son trouble.

À comprendre. Elle ne se confond pas avec un mensonge volontaire ni, automatiquement, avec le déni psychanalytique.

CARTE 015

Comment définir « Pathoplasticité » ?

> Réponse. Variation de l'expression d'un trouble selon le sujet, l'observateur, la culture, le lieu, l'époque et les situations dans lesquelles il apparaît.

CARTE 016

Comment définir « Épistémologie » ?

> Réponse. Réflexion sur les connaissances scientifiques, leurs méthodes et leurs cadres théoriques.

À comprendre. Dans le cours, elle aide à comprendre pourquoi des approches lisent différemment un même trouble.

CARTE 017

Comment définir « Diachronie » ?

> Réponse. Étude d'un phénomène dans son évolution temporelle ; elle s'oppose à une lecture limitée à un seul moment.

CARTE 018

Comment définir « Épidémiologie » ?

> Réponse. Étude de la fréquence et de la répartition des phénomènes de santé dans des populations et des facteurs qui leur sont associés.

CARTE 019

Comment définir « Étude longitudinale » ?

> Réponse. Étude suivant des sujets ou des phénomènes au fil du temps pour observer leur évolution.

CARTE 020

Comment définir « Étiologie » ?

> Réponse. Étude des causes d'une maladie ou ensemble des facteurs auxquels sa survenue est rapportée.

CARTE 021

Comment définir « Psychogenèse » ?

> Réponse. Hypothèse selon laquelle les facteurs et mécanismes à l'origine des manifestations psychopathologiques sont psychologiques et fonctionnels, c'est-à-dire sans lésion ni inflammation structurale dans la formulation du support.

À comprendre. La psychanalyse relie ainsi le symptôme à la vie psychique inconsciente et à son sens. Il s'agit d'une hypothèse étiologique ; elle ne permet pas de déclarer une origine psychique par le seul constat d'un examen sans anomalie.

CARTE 022

Comment définir « Organogenèse » ?

> Réponse. Hypothèse rapportant les troubles à des facteurs organiques, structurels ou fonctionnels, notamment cérébraux, neurochimiques ou génétiques.

CARTE 023

Comment définir « Sociogenèse » ?

Réponse. Ensemble des facteurs sociaux susceptibles de favoriser ou de contribuer à la survenue de troubles psychiques ; elle ne signifie pas qu'un contexte détermine à lui seul le devenir individuel.

CARTE 024

Comment définir « Modèle bio-psycho-social » ?

Réponse. Cadre de compréhension articulant dimensions biologiques, psychologiques et sociales dans leurs interactions, plutôt que recherchant une cause unique.

CARTE 025

Comment définir « Prophylaxie » ?

Réponse. Ensemble des mesures destinées à prévenir la survenue ou la diffusion d'une maladie ; le support la cite parmi les dimensions du champ psychiatrique.

CARTE 026

Comment définir « Réadaptation » ?

Réponse. Processus visant à soutenir le fonctionnement, l'autonomie et la participation à la vie ordinaire en tenant compte des difficultés et des ressources.

CARTE 027

Comment définir « Pathologie du psychologique » ?

Réponse. Lecture de la psychologie centrée sur ses aspects inhabituels, rares, pathologiques ou affectés d'un indice de morbidité ; premier axe de Lantéri-Laura dans le support.

CARTE 028

Comment définir « Psychologie du pathologique » ?

Réponse. Lecture globale et holistique de l'expérience vécue d'un patient, qui ne se limite pas à ce qui produit la souffrance ; deuxième axe de Lantéri-Laura.

CARTE 029

Comment définir « Clinique du pathologique » ?

Réponse. Lecture centrée sur la singularité de l'expérience de souffrance psychique de chaque sujet ; troisième axe de Lantéri-Laura.

CARTE 030

Comment définir « Fonctionnel / lésionnel » ?

> Réponse. Dans les distinctions du support, fonctionnel qualifie une perturbation du fonctionnement sans lésion structurale explicative ; lésionnel renvoie à une atteinte de structure.

À comprendre. Cette distinction descriptive ne démontre pas à elle seule une cause psychologique.

CARTE 031

Quels éléments croiser avant de qualifier un vécu de pathologique ?

> Réponse. Le contexte et les normes culturelles, le rapport à la réalité, l'intensité et la durée, la souffrance, les limitations, le retentissement et le danger pour soi ou autrui.

À comprendre. Une conduite rare ne suffit pas. L'absence de plainte peut correspondre à une méconnaissance du trouble.

CARTE 032

Quels sont les trois axes de Lantéri-Laura ?

> Réponse. Pathologie du psychologique : aspects inhabituels ou morbides ; psychologie du pathologique : expérience globale du patient ; clinique du pathologique : singularité de sa souffrance.

À comprendre. Distinguer l'objet étudié, la compréhension globale et l'approche singulière.

CARTE 033

Comment articuler psychogenèse, organogenèse et sociogenèse ?

> Réponse. Elles privilégient respectivement les facteurs psychologiques, organiques et sociaux. Une lecture bio-psycho-sociale étudie leurs interactions.

À comprendre. Un examen sans anomalie ne prouve pas à lui seul une origine psychique.

Approches et apprentissages

CARTE 034

Comment définir « Psychothérapie » ?

> Réponse. Démarche thérapeutique utilisant des moyens psychologiques et une relation structurée pour travailler une souffrance ou des difficultés psychiques ; ses objectifs et méthodes dépendent du cadre choisi.

CARTE 035

Comment définir « Approche personnaliste » ?

Réponse. Dans le classement du support, approche centrée sur le sujet et les facteurs individuels ; elle comprend notamment les lectures psychanalytique, biologique et cognitive.

CARTE 036

Comment définir « Approche environnementaliste » ?

Réponse. Approche privilégiant l'environnement du sujet : situation-problème, contexte, culture et facteurs situationnels.

À comprendre. Le support y classe les psychothérapies comportementales, ethnopsychologiques et sociales.

CARTE 037

Comment définir « Approche interactionniste » ?

Réponse. Approche tenant compte des contributions de la personne et de la situation, mais aussi de leur interaction : relations et influences réciproques entre personne et contexte.

À comprendre. Le support y situe les psychothérapies systémiques et écosystémiques.

CARTE 038

Comment définir « Approche syncrétique » ?

Réponse. Dans le support, démarche qui va au-delà de la simple juxtaposition de techniques pour articuler plusieurs approches dans un modèle de causalité multiple et bidirectionnelle.

À comprendre. Les TCC combinent la démarche comportementale et les stratégies cognitives, avec une place pour les émotions.

CARTE 039

Comment définir « Approche biologique » ?

Réponse. Lecture recherchant les éléments organiques des troubles et les modifications du fonctionnement du système nerveux susceptibles d'y contribuer.

CARTE 040

Comment définir « Béhaviorisme » ?

Réponse. Approche centrée sur les comportements observables et leurs lois d'apprentissage, en particulier les conditions de leur acquisition et de leur maintien.

CARTE 041

Comment définir « Conditionnement classique ou répondant » ?

Réponse. Apprentissage par association de stimuli, par lequel un stimulus initialement neutre peut déclencher une réponse ; l'exemple classique est celui du signal associé à la salivation.

CARTE 042

Comment définir « Conditionnement opérant ou instrumental » ?

Réponse. Apprentissage dans lequel les conséquences d'un comportement influencent sa probabilité de répétition ; il concerne le comportement et ses effets dans l'environnement.

CARTE 043

Comment définir « Apprentissage vicariant » ?

Réponse. Apprentissage reposant sur l'observation des conduites d'un modèle et de leurs conséquences, sans devoir faire soi-même toute l'expérience.

CARTE 044

Comment définir « Renforcement » ?

Réponse. Conséquence qui augmente la probabilité de répétition d'un comportement dans l'apprentissage opérant ; le terme décrit une fonction, pas uniquement une récompense agréable.

CARTE 045

Comment définir « Extinction » ?

Réponse. Affaiblissement d'une réponse apprise lorsque les conditions qui la maintenaient cessent ; l'oral l'évoque à propos des conséquences accordées à une conduite.

CARTE 046

Comment définir « Approche systémique » ?

Réponse. Lecture considérant la personne dans les systèmes auxquels elle appartient et les interactions circulaires qui participent au fonctionnement et à la souffrance.

CARTE 047

Comment définir « Système relationnel » ?

Réponse. Ensemble d'éléments en interaction, par exemple une famille, dont les règles et les échanges influencent les membres et sont influencés par eux.

CARTE 048

Comment définir « Causalité circulaire » ?

Réponse. Manière de comprendre des influences réciproques : chaque réaction agit sur les autres et contribue à entretenir ou modifier le fonctionnement du système.

CARTE 049

Comment définir « Patient désigné » ?

Réponse. Dans le modèle systémique, personne portant le symptôme à travers lequel se manifeste une difficulté relationnelle du système ; ce terme ne signifie pas qu'elle serait volontairement malade.

CARTE 050

Comment définir « Métacommunication » ?

Réponse. Communication portant sur la manière dont on communique : implicites, règles, malentendus, place du verbal et du non-verbal.

CARTE 051

Comment définir « Thérapies cognitivo-comportementales · TCC » ?

Réponse. Approches associant l'histoire des apprentissages à la manière subjective de vivre les situations : pensées, croyances, schémas, émotions et comportements.

À comprendre. Elles visent à modifier les fonctionnements inadaptés ou, lorsque cela n'est pas possible, à en développer l'acceptation. Le travail comprend analyse du problème dans l'ici et maintenant, objectifs et moyens définis avec le patient, exercices adaptés en séance et entre les séances, puis évaluation des progrès et de la poursuite du traitement.

CARTE 052

Comment définir « Cognition » ?

Réponse. Ensemble des opérations par lesquelles le sujet traite l'information, se représente les situations, pense, juge et interprète.

CARTE 053

Comment définir « Schéma cognitif » ?

Réponse. Structure issue des expériences et connaissances qui organise les interprétations et oriente pensées, émotions et comportements, parfois sans que le sujet en ait conscience.

CARTE 054

Comment définir « Biais cognitif » ?

Réponse. Orientation ou déformation du traitement de l'information qui influence l'interprétation d'une situation ; le cours l'évoque lorsqu'elle contribue à maintenir la souffrance.

CARTE 055

Comment définir « Inconscient cognitif » ?

Réponse. Processus cognitifs se déroulant hors de la conscience immédiate.

À comprendre. Il ne correspond pas nécessairement à des contenus refoulés en conflit avec des interdits.

CARTE 056

Comment définir « Rumination » ?

Réponse. Reprise répétitive de pensées autour d'une difficulté ou d'une inquiétude, susceptible d'entretenir la souffrance sans aboutir à une résolution.

CARTE 057

Comment définir « Évitement » ?

Réponse. Conduite consistant à se tenir à distance d'une situation ou d'un vécu redouté ; elle peut participer au maintien d'un apprentissage problématique.

CARTE 058

Comment définir « Alliance thérapeutique » ?

Réponse. Qualité de la collaboration et du lien de confiance entre personne soignée et professionnel autour du travail de soin ; l'oral la présente comme un facteur relationnel transversal.

CARTE 059

Comment définir « Effet placebo » ?

Réponse. Effet associé notamment aux attentes et au contexte de soin, utilisé à l'oral pour illustrer les interactions entre dimensions psychiques et corporelles.

À comprendre. L'exemple vise à éviter d'opposer somatique et psychologique ; les pourcentages approximatifs cités ne sont pas des valeurs à mémoriser.

CARTE 060

Comment distinguer les trois modalités d'apprentissage présentées ?

> Réponse. Classique ou répondant : association de stimuli ; opérant ou instrumental : modification d'un comportement par ses conséquences ; vicariant : apprentissage par observation d'un modèle et de ce qui lui arrive.

À comprendre. L'observation permet d'apprendre sans vivre soi-même chaque conséquence.

CARTE 061

Quels sont les deux niveaux de changement en approche systémique ?

> Réponse. Un changement peut concerner des éléments au sein d'un système ou modifier les règles qui organisent le système lui-même.

À comprendre. Le travail s'intéresse aux interactions et aux ressources, sans désigner une famille comme cause unique ni imposer que tous soient toujours réunis.

CARTE 062

Quelles dimensions les TCC mettent-elles en relation ?

> Réponse. Les pensées et schémas cognitifs, les émotions et les comportements. Leurs interactions peuvent entretenir une difficulté, notamment par l'évitement.

À comprendre. Les objectifs sont construits avec le patient ; les exercices et leur progression sont adaptés et réévalués.

Histoire et concepts psychanalytiques

CARTE 063

Comment définir « Psychanalyse » ?

> Réponse. À la fois procédé d'investigation du psychisme inconscient, méthode de traitement et théorie de la vie psychique issue de cette expérience.

CARTE 064

Comment définir « Hystérie » ?

> Réponse. Notion historique désignant des manifestations fonctionnelles diverses, notamment corporelles, interprétées dans le cours en relation avec des conflits psychiques et la conversion.

À comprendre. Elle ne se confond pas avec une simulation.

CARTE 065

Comment définir « Conversion » ?

Réponse. Dans le modèle psychanalytique du cours, transposition corporelle d'un conflit ou d'un affect, donnant une expression somatique au symptôme ; cette lecture ne se déduit pas de la seule absence de lésion retrouvée.

CARTE 066

Comment définir « Atteinte fonctionnelle » ?

Réponse. Perturbation d'une fonction sans lésion structurale explicative identifiée dans la présentation considérée ; le trouble est vécu réellement et demande une évaluation clinique.

CARTE 067

Comment définir « Corps fantasmatique » ?

Réponse. Corps tel qu'il est représenté et investi psychiquement, avec une organisation subjective qui ne se confond pas avec le découpage anatomique.

CARTE 068

Comment définir « Belle indifférence » ?

Réponse. Expression historique de Charcot désignant une apparente absence d'inquiétude devant certains symptômes ; elle n'est ni une preuve de simulation ni un critère suffisant de diagnostic.

CARTE 069

Comment définir « Prodrome » ?

Réponse. Manifestation annonciatrice précédant un tableau clinique ; dans la description de Charcot, les prodromes précèdent les quatre périodes de la crise.

CARTE 070

Comment définir « Clownisme » ?

Réponse. Terme historique désignant les contorsions et attitudes corporelles spectaculaires de la deuxième période de la grande crise décrite par Charcot.

CARTE 071

Comment définir « Suggestion post-hypnotique » ?

Réponse. Consigne donnée dans un état hypnotique pouvant influencer ensuite une conduite sans que le sujet se rappelle consciemment la consigne ; le cours l'utilise pour introduire des processus psychiques non conscients.

CARTE 072

Comment définir « Méthode cathartique » ?

Réponse. Méthode historique associant la mise en récit d'événements pénibles à la libération des affects qui leur restent attachés, notamment dans les travaux de Breuer et Freud.

CARTE 073

Comment définir « Catharsis » ?

Réponse. Décharge ou libération émotionnelle ; dans le contexte historique du cours, elle désigne l'apaisement recherché par l'expression d'affects jusque-là retenus.

CARTE 074

Comment définir « Abréaction » ?

Réponse. Décharge émotionnelle d'un affect lié à un événement pénible ou traumatique, obtenue notamment lors de son évocation dans la méthode cathartique.

CARTE 075

Comment définir « Talking cure » ?

Réponse. Expression associée à Anna O. désignant la cure par la parole, dans laquelle la mise en récit participe au travail thérapeutique.

CARTE 076

Comment définir « Associations libres » ?

Réponse. Procédé invitant le sujet à exprimer ce qui lui vient à l'esprit en tentant de limiter la sélection volontaire, afin d'explorer les liens entre ses contenus psychiques.

CARTE 077

Comment définir « Réminiscence » ?

Réponse. Retour d'un souvenir ou d'une trace du passé ; le récit historique de l'hystérie insiste sur l'action persistante de souvenirs chargés d'affects.

CARTE 078

Comment définir « Théorie de la séduction » ?

Réponse. Première hypothèse étiologique freudienne reliant certaines névroses au souvenir de scènes sexuelles traumatiques précoces ; le terme historique ne signifie pas un consentement de l'enfant.

CARTE 079

Comment définir « Fantasme » ?

Réponse. Scénario ou représentation psychique exprimant des désirs et leurs conflits, conscient ou inconscient.

À comprendre. Il appartient à la réalité psychique et ne démontre pas à lui seul la réalité matérielle d'un événement.

CARTE 080

Comment définir « Réalité psychique » ?

Réponse. Valeur et effets qu'ont pour le sujet ses représentations, désirs et fantasmes, indépendamment de leur correspondance exacte avec un événement extérieur.

CARTE 081

Comment définir « Théorie du fantasme » ?

Réponse. Hypothèse reconnaissant le rôle des désirs et scénarios psychiques, notamment œdipiens, dans certains conflits ; le cours précise qu'elle n'efface pas la réalité des traumatismes.

CARTE 082

Comment définir « Formation de compromis » ?

Réponse. Production psychique qui exprime de façon transformée des forces opposées, notamment un désir et une défense ; rêve, lapsus et certains symptômes en sont des exemples dans le modèle.

CARTE 083

Comment définir « Contenu latent » ?

Réponse. Pensées, désirs et associations sous-jacents au rêve, distingués de son récit manifeste dans la théorie psychanalytique.

CARTE 084

Comment définir « Contenu manifeste » ?

Réponse. Rêve tel qu'il est vécu et raconté au réveil, après transformation de ses contenus sous-jacents.

CARTE 085

Comment définir « Reste diurne » ?

Réponse. Élément d'une journée qui peut réactiver des contenus psychiques et fournir du matériau au rêve.

CARTE 086

Comment définir « Condensation » ?

Réponse. Processus réunissant plusieurs représentations ou chaînes associatives dans un même élément, par exemple un personnage de rêve combinant plusieurs personnes.

CARTE 087

Comment définir « Figuration » ?

Réponse. Transformation de pensées en images ou en formes représentables dans le rêve, présentée à l'oral comme un des procédés du travail onirique.

CARTE 088

Comment définir « Élaboration secondaire » ?

Réponse. Travail qui contribue à organiser les éléments du rêve en un récit présentant une certaine cohérence.

CARTE 089

Comment définir « Lapsus » ?

Réponse. Erreur de parole ou d'expression interprétable, dans la lecture psychanalytique, comme une manifestation transformée d'un contenu psychique ; son sens ne se conclut pas automatiquement d'une erreur isolée.

CARTE 090

Comment définir « Acte manqué » ?

Réponse. Action ou omission qui échoue au regard de l'intention consciente et peut exprimer, selon le modèle, une tendance inconsciente ; son interprétation nécessite le contexte du sujet.

CARTE 091

Comment définir « État hypnoïde » ?

Réponse. État de conscience modifié, décrit dans le cas historique d'Anna O., au cours duquel un mot lié à ses préoccupations pouvait susciter une narration spontanée.

À comprendre. Il est présenté dans l'histoire de la méthode cathartique, sans être assimilé au sommeil ordinaire.

CARTE 092

Comment définir « Rêve » ?

Réponse. Formation étudiée en psychanalyse comme expression transformée de contenus psychiques.

À comprendre. L'oral distingue contenu latent et contenu manifeste, et décrit condensation, déplacement, figuration et élaboration secondaire. L'exploration repose sur les associations du rêveur, sans clé symbolique universelle.

CARTE 093

Comment définir « Régression topique » ?

Réponse. Retour, dans la lecture orale du rêve, vers des modalités plus imagées et sensorielles de représentation plutôt que la seule pensée verbale.

À comprendre. C'est une modalité de régression dans un modèle de fonctionnement psychique, pas un déplacement anatomique.

CARTE 094

Quels sont les trois sens de la psychanalyse ?

Réponse. Un procédé d'investigation des processus inconscients, une méthode de traitement et une théorie issue de cette expérience.

À comprendre. Distinguer méthode d'exploration, pratique thérapeutique et construction théorique.

CARTE 095

Dans la description historique de Charcot, comment s'organise la grande crise ?

Réponse. Les prodromes précèdent quatre périodes : période épileptique ou épileptoïde, contorsions ou clownisme, attitudes passionnelles, puis période terminale.

À comprendre. Les prodromes ne constituent pas une cinquième période équivalente ; cette description historique ne permet pas d'identifier toute crise à une épilepsie.

CARTE 096

Quels mécanismes composent le travail du rêve dans le modèle psychanalytique ?

Réponse. Condensation : plusieurs éléments réunis ; déplacement : intensité reportée ; figuration : pensées rendues en images ; élaboration secondaire : organisation d'un récit plus cohérent.

À comprendre. Le contenu manifeste est le rêve raconté ; le latent est exploré par les associations du rêveur, sans dictionnaire universel.

Métapsychologie et pulsions

CARTE 097

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Métapsychologie » ?

> Réponse. Partie théorique de la psychanalyse décrivant les processus psychiques selon les points de vue topique, économique et dynamique.

CARTE 098

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Appareil psychique » ?

> Réponse. Modèle ou fiction représentant un ensemble organisé de systèmes ou d'instances aux fonctions différentes, qui se constitue progressivement en transmettant et transformant les excitations internes et externes.

À comprendre. Son travail est de les maîtriser, réduire ou transformer et de maintenir leur niveau aussi bas que possible, par protection contre l'externe et défense ou décharge de l'interne. Il ne désigne pas un organe anatomique.

CARTE 099

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Excitation » ?

> Réponse. Stimulation interne ou externe qui impose au psychisme un travail de maîtrise, de transformation ou de décharge dans le modèle du cours.

CARTE 100

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Pulsion » ?

> Réponse. Poussée liée à une source somatique interne, imposant un travail à l'appareil psychique.

À comprendre. Elle correspond dans le cours à un afflux constant d'excitations internes auquel on ne peut se soustraire comme à une stimulation extérieure. Elle se caractérise par poussée, source, but et objet. Contrairement à l'instinct décrit dans le support, elle reste relativement indéterminée quant aux conduites, aux buts intermédiaires et aux objets procurant satisfaction, qui dépendent de l'histoire du sujet. Affect et représentation en sont les représentants psychiques.

CARTE 101

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Poussée pulsionnelle » ?

> Réponse. Aspect moteur et charge énergétique de la pulsion, c'est-à-dire sa pression et ce qui pousse à agir.

CARTE 102

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Source pulsionnelle » ?

Réponse. Processus somatique, dans un organe ou une zone du corps, à l'origine de l'excitation représentée psychiquement par la pulsion.

CARTE 103

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « But pulsionnel » ?

Réponse. Satisfaction finale obtenue, dans le modèle, par suppression de l'état d'excitation à la source pulsionnelle, disparition de la tension ou décharge.

À comprendre. Le terme peut également désigner les voies, activités ou mécanismes intermédiaires permettant d'atteindre cette satisfaction ; ces buts peuvent être multiples et parcellaires.

CARTE 104

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Objet pulsionnel » ?

Réponse. Ce par quoi ou en quoi la pulsion peut obtenir satisfaction : personne entière, partie de personne, objet réel ou fantasmatique ; il est contingent et dépend de l'histoire.

CARTE 105

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Instinct » ?

Réponse. Dans la distinction du support, comportement animal fixé par l'hérédité, caractéristique d'une espèce, relativement stable dans son déroulement, adapté à son objet et variant peu entre individus.

À comprendre. Il suit une séquence temporelle peu susceptible de bouleversement et paraît répondre à une finalité. La pulsion est décrite, à l'inverse, comme plus indéterminée quant aux comportements, objets et buts.

CARTE 106

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Zone érogène » ?

Réponse. Région corporelle pouvant être source de plaisir dans la théorie, notamment les zones cutanéo-muqueuses et d'échange avec l'entourage ; la notion est ensuite étendue au corps entier.

CARTE 107

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Affect » ?

Réponse. Qualité de l'énergie associée à la pulsion, positive ou négative.

À comprendre. Le terme peut désigner tout état affectif agréable ou désagréable, vague ou précis, sous forme d'une décharge massive et ponctuelle ou d'une tonalité générale durable, comme l'humeur. Affect et représentation constituent dans le cours les deux représentants psychiques de la pulsion.

CARTE 108

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Représentation » ?

Réponse. Contenu de pensée, idée de quelque chose ou image, s'appuyant sur des traces mnésiques.

À comprendre. Le support distingue représentations de mots, principalement acoustico-verbales, et représentations de choses, principalement imagées. Avec l'affect, elle constitue un représentant psychique de la pulsion ; dans le refoulement névrotique, c'est la représentation conflictuelle qui est maintenue dans l'inconscient.

CARTE 109

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Représentation de mot » ?

Réponse. Représentation verbale, principalement acoustico-verbale dans le support, distinguée des représentations de choses.

CARTE 110

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Représentation de chose » ?

Réponse. Représentation essentiellement imagée ou sensorielle d'un objet ou d'une expérience, distinguée de sa formulation verbale.

CARTE 111

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Trace mnésique » ?

Réponse. Trace conservée d'une expérience, servant de support au souvenir et aux représentations dans le modèle psychique.

CARTE 112

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Point de vue topique » ?

Réponse. Lecture de l'appareil psychique selon des systèmes ou instances ayant des fonctions et règles différentes, sans supposer de localisation anatomique.

CARTE 113

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Perception-conscience · Pc-Cs » ?

Réponse. Système situé à la périphérie de l'appareil psychique dans la première topique.

À comprendre. Il reçoit les informations extérieures et les sensations internes de plaisir et de déplaisir ; il est le siège des processus de pensée consciente, de l'accès aux souvenirs pour raisonner et du contrôle moteur. Aucune trace durable ne s'y inscrit dans ce modèle ; l'énergie y est mobile, permettant notamment l'attention portée à différents éléments.

CARTE 114

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Préconscient · Pcs » ?

> Réponse. Système situé entre l'inconscient et la perception-conscience.

À comprendre. Ses contenus, notamment les représentations de mots, sont absents du champ actuel de la conscience mais peuvent devenir conscients assez facilement. L'énergie y est plutôt liée. L'oral l'illustre par un savoir disponible, comme des tables de multiplication que l'on rappelle pour effectuer un calcul.

CARTE 115

Dans la première topique freudienne, quels contenus appartiennent à l'inconscient ?

> Réponse. Partie la plus archaïque de l'appareil psychique, proche des sources pulsionnelles. Ses contenus comprennent notamment les représentants de pulsions et représentations de choses refoulés, dont des désirs infantiles, qui restent actifs et cherchent à revenir dans la conscience et l'action, par exemple dans le rêve, le lapsus ou le symptôme.

CARTE 116

Quelles lois de fonctionnement caractérisent l'inconscient dans la théorie freudienne ?

> Réponse. Dans cette théorie, son fonctionnement comporte absence de contradiction, de négation, de doute et de degré dans la certitude, atemporalité et indifférence à la réalité extérieure, remplacée par la réalité psychique. L'énergie y circule librement.

CARTE 117

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Censure » ?

> Réponse. Fonction figurée comme une barrière sélective entre inconscient et préconscient.

À comprendre. Elle interdit l'accès de certains désirs ou représentations à la perception-conscience et participe ainsi au refoulement. Elle impose des déformations importantes aux contenus qui franchissent cette limite, comme dans le travail du rêve.

CARTE 118

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Pare-excitation » ?

> Réponse. Fonction protectrice figurée à la surface de l'appareil psychique, limitant l'irruption d'excitations externes trop intenses ; l'environnement soutient cette protection au début de la vie.

CARTE 119

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Traumatisme psychique » ?

> Réponse. Dans le cadre du cours, expérience d'excitation débordant les capacités de maîtrise et de traitement psychique, pensée comme une effraction du pare-excitation.

À comprendre. Ses effets ne se déduisent pas du seul événement.

CARTE 120

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Ça » ?

> Réponse. Instance constituant le pôle pulsionnel et le réservoir de l'énergie pulsionnelle de la personnalité.

À comprendre. Ses contenus sont inconscients et son extrémité s'ouvre du côté somatique. Le support le décrit comme un ensemble de tendances contradictoires, cherchant satisfaction et ignorant les jugements de valeur, le bien, le mal et la morale.

CARTE 121

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Moi » ?

> Réponse. Instance médiatrice chargée des intérêts de la totalité de la personne entre revendications du Ça, impératifs du Surmoi et contraintes de la réalité.

À comprendre. Son autonomie reste fragile face à ces exigences. Le Moi est à la fois un appareil adaptatif se différenciant du Ça au contact de la réalité et une unité assurant stabilité et identité par les identifications. Il comporte une part consciente, recouvre largement le préconscient et possède une part inconsciente importante, notamment son pôle défensif mobilisé face à l'angoisse.

CARTE 122

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Surmoi » ?

> Réponse. Instance présentée comme héritière du complexe d'Œdipe et issue de l'intériorisation des exigences et interdits parentaux, sociaux et culturels, notamment les interdits de l'inceste et du meurtre.

À comprendre. Elle exerce trois fonctions : auto-observation critique, conscience morale et censure à l'égard du Moi, formation des idéaux. Le cours associe la culpabilité à la transgression des interdits et la honte à l'écart envers l'Idéal du Moi.

CARTE 123

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Idéal du Moi » ?

> Réponse. Ensemble des idéaux et de l'image de ce que le sujet voudrait être ; l'écart à cet idéal peut mobiliser la honte dans la distinction faite à l'oral.

CARTE 124

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Culpabilité » ?

> Réponse. Affect lié au sentiment d'avoir transgressé un interdit ou fait du mal à un autre, relié au Surmoi et au lien à l'objet dans le cours.

CARTE 125

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Honte » ?

> Réponse. Affect touchant l'image et la valeur de soi, notamment l'écart entre ce que l'on est et son idéal ; l'oral la distingue de la culpabilité.

CARTE 126

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Point de vue économique » ?

> Réponse. Lecture des processus psychiques selon les quantités d'excitation, leurs variations, leur circulation et leur répartition.

CARTE 127

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Principe de constance » ?

> Réponse. Tendance de l'appareil psychique, dans la théorie, à maintenir les quantités d'excitation à un niveau aussi bas que possible.

CARTE 128

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Principe de plaisir » ?

> Réponse. Principe selon lequel l'activité psychique évite le déplaisir et recherche le plaisir en réduisant au minimum la tension.

À comprendre. Dans le modèle, l'augmentation des quantités d'excitation correspond au déplaisir et leur diminution au plaisir. Ce principe régit les phénomènes inconscients et le Ça ; il est modifié par le principe de réalité.

CARTE 129

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Principe de réalité » ?

> Réponse. Principe régulateur qui modifie la recherche de plaisir : la satisfaction n'emprunte plus nécessairement la voie la plus courte mais accepte détours et ajournement en fonction du monde extérieur.

À comprendre. Il se construit progressivement avec la confrontation à la réalité et le développement de l'attention, du jugement, de la mémoire et de la pensée. Il prévaut au niveau du Moi.

CARTE 130

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Processus primaire » ?

> Réponse. Mode de fonctionnement caractéristique de l'inconscient, où l'énergie circule librement d'une représentation à l'autre, notamment par condensation et déplacement.

CARTE 131

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Processus secondaire » ?

> Réponse. Mode de fonctionnement des systèmes préconscient et conscient, dans lequel l'énergie est liée à des représentations investies de manière plus stable et circule de façon contrôlée.

À comprendre. Il permet l'ajournement de la satisfaction grâce à la pensée vigilante, l'attention, le jugement, le raisonnement et l'action contrôlée.

CARTE 132

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Libido » ?

> Réponse. Énergie des pulsions sexuelles au sens élargi de la psychanalyse ; elle peut être investie dans le Moi, des objets, des représentations ou des activités.

CARTE 133

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Investissement libidinal » ?

> Réponse. Attachement ou allocation d'énergie psychique à une représentation, un objet, une partie du corps ou une activité dans le modèle économique.

CARTE 134

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Libido narcissique » ?

> Réponse. Part de l'investissement libidinal dirigée vers le Moi ; elle participe à l'image, à la valeur et au soin de soi.

CARTE 135

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Libido objectale » ?

> Réponse. Part de l'investissement libidinal dirigée vers des objets extérieurs au Moi, notamment des personnes aimées.

CARTE 136

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Compulsion de répétition » ?

> Réponse. Tendance inconsciente à répéter des expériences ou situations pénibles, qui dépasse une explication fondée sur la seule recherche de plaisir ; le cours l'évoque notamment à propos du traumatisme.

CARTE 137

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Point de vue dynamique » ?

Réponse. Lecture des phénomènes psychiques comme résultant du jeu et du conflit entre forces ou exigences opposées, particulièrement d'origine pulsionnelle.

CARTE 138

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Conflit psychique » ?

Réponse. Opposition d'exigences internes incompatibles, par exemple désir et interdit ou désir et défense ; il peut être manifeste ou latent et s'exprimer indirectement.

CARTE 139

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Dualisme pulsionnel » ?

Réponse. Construction théorique opposant deux groupes de pulsions ; le premier dualisme distingue autoconservation et sexualité, le second pulsions de vie et de mort.

CARTE 140

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Pulsions d'autoconservation » ?

Réponse. Pulsions orientées vers la préservation de l'individu et ses fonctions vitales, telles que nutrition, excrétion ou autoprotection dans le modèle.

CARTE 141

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Pulsions sexuelles » ?

Réponse. Pulsions recherchant un plaisir corporel qui dépasse la seule satisfaction des besoins ; le terme est plus large que les conduites génitales adultes.

CARTE 142

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Étayage » ?

Réponse. Appui initial des pulsions sexuelles sur les fonctions d'autoconservation, auxquelles elles empruntent source et objet avant de rechercher une prime de plaisir indépendante du besoin.

CARTE 143

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Pulsion partielle » ?

Réponse. Composante pulsionnelle à source et but locaux, fonctionnant initialement de façon relativement autonome avant l'organisation sous le primat génital.

CARTE 144

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Pulsions de vie · Éros » ?

Réponse. Dans le second dualisme, ensemble associant sexualité et autoconservation, orienté vers la liaison et la constitution d'unités plus grandes.

CARTE 145

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Pulsion de mort · Thanatos » ?

Réponse. Hypothèse du second dualisme d'une tendance à la réduction complète des tensions et au retour du vivant à l'inorganique.

À comprendre. Dans le support, elle serait d'abord tournée vers l'intérieur et l'autodestruction, puis vers l'extérieur sous forme de pulsion d'agression. Elle est mise en lien avec répétition et sadomasochisme. C'est un concept métapsychologique ; elle est généralement pensée comme intriquée aux pulsions de vie.

CARTE 146

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Intrication pulsionnelle » ?

Réponse. Association des tendances de vie et de mort dans une même expression psychique ou conduite, plutôt que leur présence indépendante et pure.

CARTE 147

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Névrose de destinée » ?

Réponse. Expression historique employée à l'oral pour décrire des répétitions de situations relationnelles ou de vie pénibles, apparemment subies comme un destin, et rapprochées de la compulsion de répétition.

À comprendre. Elle ne permet pas d'attribuer au sujet la responsabilité des violences qu'il subit.

CARTE 148

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Carence du préconscient » ?

Réponse. Hypothèse psychanalytique évoquée à l'oral lorsque des contenus trop chargés d'affects deviennent difficiles à mobiliser et à penser.

À comprendre. L'action peut alors court-circuiter l'élaboration. Cette lecture ne constitue pas un critère diagnostique suffisant d'addiction, de trouble alimentaire ou de passage à l'acte.

CARTE 149

Quels sont les quatre caractères de la pulsion dans le modèle freudien ?

> Réponse. Poussée : force ou pression ; source : origine somatique ; but : satisfaction ; objet : ce par quoi la satisfaction est atteinte.

À comprendre. L'objet peut être une personne, une partie de personne ou une représentation ; il ne se limite pas à une chose matérielle.

CARTE 150

Quels systèmes distingue la première topique et quelles instances distingue la seconde ?

> Réponse. Première topique : perception-conscience, préconscient, inconscient. Seconde topique : Ça, Moi, Surmoi.

À comprendre. Le Moi et le Surmoi comportent de l'inconscient. Les deux topiques ne se superposent pas terme à terme et ne localisent pas des organes.

CARTE 151

Comment distinguer processus primaires et secondaires ?

> Réponse. Primaires : énergie libre, condensation et déplacement, fonctionnement de l'inconscient. Secondaires : énergie liée, jugement, raisonnement et action contrôlée, surtout dans le préconscient et le conscient.

À comprendre. Le principe de réalité permet d'aménager et de différer la satisfaction ; il ne supprime pas la recherche de plaisir.

CARTE 152

Quels sont les deux dualismes pulsionnels freudiens présentés ?

> Réponse. Le premier oppose autoconservation et sexualité ; le second oppose pulsions de vie et pulsion de mort.

À comprendre. L'intrication désigne leur combinaison dans le second modèle. Ces notions sont des constructions métapsychologiques, sans mesure directe de forces isolées.

CARTE 153

Comment distinguer culpabilité et honte dans le modèle présenté ?

> Réponse. La culpabilité se rapporte notamment à une transgression ou au sentiment d'avoir fait du mal ; la honte touche l'image de soi et l'écart à l'Idéal du Moi.

À comprendre. Les deux vécus peuvent coexister ; ils ne sont pas de simples synonymes.

Développement, objets et angoisses

CARTE 154

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Sexualité infantile » ?

Réponse. Ensemble d'activités précoces procurant un plaisir corporel dépassant la satisfaction du besoin, avec zones érogènes, étayage, pulsions partielles et auto-érotisme ; elle n'est pas une sexualité génitale adulte.

CARTE 155

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Auto-érotisme » ?

Réponse. Mode de satisfaction pulsionnelle trouvé dans le corps propre, initialement au niveau de zones partielles, sans recours nécessaire à un objet extérieur.

CARTE 156

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Narcissisme » ?

Réponse. Investissement libidinal du Moi et de l'image unifiée de son corps comme objet d'amour.

À comprendre. Dans le cours, le sujet se prend lui-même comme objet ; la notion n'a pas d'emblée une connotation négative. Elle concerne identifications, idéaux, estime de soi et image de soi. L'équilibre des investissements varie entre libido narcissique et libido d'objet.

CARTE 157

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Amour d'objet » ?

Réponse. Investissement affectif et libidinal d'un autre objet que le Moi, notamment une personne reconnue comme extérieure et distincte.

CARTE 158

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Objet partiel » ?

Réponse. Partie d'une personne ou élément investi psychiquement, par exemple le sein dans le stade oral, plutôt que la personne reconnue dans sa totalité.

CARTE 159

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Objet total ou global » ?

Réponse. Personne investie et reconnue comme une totalité distincte, pouvant réunir des qualités appréciées et frustrantes.

CARTE 160

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Objet interne » ?

Réponse. Représentation psychiquement intériorisée d'un objet ou du lien à celui-ci ; elle permet notamment de conserver un sentiment du lien en son absence.

CARTE 161

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Objet externe » ?

Réponse. Objet ou personne existant à l'extérieur du sujet, avec lequel il entre réellement en relation ; il se distingue de sa représentation interne.

CARTE 162

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Incorporation » ?

Réponse. But pulsionnel consistant à faire entrer en soi un objet de manière réelle ou fantasmatique, particulièrement important dans la description du stade oral.

CARTE 163

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Stade oral » ?

Réponse. Repère développemental, de la naissance au sevrage mais se prolongeant au-delà, où prédomine la zone buccale comme source de plaisir.

À comprendre. Le support étend cette source au carrefour aérodigestif, à la phonation, aux organes des sens et à la peau comme zones d'échange avec l'entourage. L'objet premier est le sein ou son substitut, objet partiel ; le but est l'incorporation réelle ou fantasmatique. Il comprend un temps oral primitif de succion et un temps sadique-oral de morsure et d'ambivalence.

CARTE 164

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Sous-stade oral primitif » ?

Réponse. Temps de l'oralité dominé par succion et aspiration, avec une faible différenciation entre sujet et objet dans le modèle.

CARTE 165

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Sous-stade sadique-oral » ?

Réponse. Temps de l'oralité dominé par la morsure et une incorporation pouvant être vécue fantasmatiquement comme destruction, avec émergence de l'ambivalence.

CARTE 166

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Sevrage » ?

Réponse. Arrêt ou modification de l'alimentation au sein, mobilisant dans la lecture du cours des enjeux de séparation et de satisfaction orale, sans définir un âge universel de fin du stade oral.

CARTE 167

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Stade anal » ?

Réponse. Repère surtout situé dans les deuxième et troisième années, se prolongeant au-delà et lié aux acquisitions de maîtrise : marche, parole, pensée et contrôle sphinctérien.

À comprendre. Sa source est la zone anale et intestinale d'excrétion, son objet les fèces vécues comme partie du corps propre, ses buts l'expulsion et la rétention. Dans le modèle, il soutient les distinctions dedans-dehors et Moi/non-Moi, et les échanges avec l'entourage, avec des équivalences symboliques entre fèces, argent et cadeau.

CARTE 168

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Phase expulsive » ?

Réponse. Sous-temps anal dominé par l'excrétion et l'expulsion.

À comprendre. Le support lui associe une dimension auto-érotique, le rapport aux demandes parentales et une dimension sadique, figurée comme destruction de l'objet-fèces et agressivité envers l'entourage.

CARTE 169

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Phase rétentive » ?

Réponse. Sous-temps anal dominé par la rétention.

À comprendre. Le support lui associe une dimension masochique du fait de retenir et une dimension sadique du fait de garder l'objet précieux demandé par les adultes ; cette opposition participe à l'émergence de l'ambivalence dans le modèle.

CARTE 170

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Ambivalence » ?

Réponse. Coexistence de sentiments ou tendances opposés envers un même objet, notamment amour et hostilité ; elle ne signifie pas simplement changer successivement d'avis.

CARTE 171

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Stade phallique » ?

> Réponse. Repère à partir d'environ trois ans où commence une unification des pulsions partielles sous une prévalence génitale, avec curiosité pour les organes génitaux, la différence des sexes et les origines.

À comprendre. Dans la conception freudienne exposée, le monisme phallique oppose présence et absence du pénis. Ce stade reste dit prégénital car le phallus est surtout investi comme puissance ou complétude et comme objet partiel possédé ou non. Il ouvre vers le complexe d'Œdipe et ses angoisses de castration. Cette théorie historique est discutée dans le cours oral.

CARTE 172

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Monisme phallique » ?

> Réponse. Hypothèse freudienne selon laquelle l'enfant se représenterait d'abord une seule référence génitale, en opposant présence et absence du pénis ; le cours oral rappelle que cette conception est discutée.

CARTE 173

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Théories sexuelles infantiles » ?

> Réponse. Explications élaborées par l'enfant pour donner sens aux origines, à la procréation et à la naissance, à partir de ses représentations et de son niveau de développement.

CARTE 174

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Complexe d'Œdipe » ?

> Réponse. Ensemble de désirs amoureux et hostiles à l'égard des deux figures parentales, avec formes positive, négative et complète dans la théorie freudienne.

À comprendre. Le support lui attribue un rôle nodal : dépassement de l'auto-érotisme, orientation vers des objets extérieurs globaux, entiers et sexués, triangulation, genèse du Surmoi et de l'Idéal du Moi. Sa résolution implique renoncement à la possession des objets parentaux, intériorisation des interdits de l'inceste et du meurtre, identifications et perspective d'autres objets d'amour : passer de l'avoir à l'être comme.

CARTE 175

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Œdipe positif, négatif et complet » ?

> Réponse. Forme positive : attirance pour le parent de sexe opposé et rivalité envers celui de même sexe ; forme négative : distribution inverse ; forme complète : coexistence et articulation des deux dans le modèle.

CARTE 176

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Triangulation » ?

> Réponse. Accès à une relation où un tiers a une place et où l'objet aimé peut investir un autre lien ; elle implique de sortir d'une exclusivité à deux.

CARTE 177

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Période de latence » ?

> Réponse. Période située approximativement de six-sept ans à la puberté, après l'Œdipe, décrite comme un repos seulement apparent du fait du refoulement.

À comprendre. Ce n'est pas un stade car elle n'est pas un nouveau moment d'organisation autour d'une zone érogène. Les interdits, l'immaturité et les contraintes externes contribuent à l'inhibition du but sexuel ; la libido est réorientée vers les apprentissages, les activités, les liens tendres avec les parents et de nouveaux objets sociaux.

CARTE 178

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Amnésie infantile » ?

> Réponse. Rareté ou absence de souvenirs conscients des premières années de vie, reliée au refoulement dans le cadre explicatif du cours.

CARTE 179

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Primat du génital » ?

> Réponse. Organisation dans laquelle les pulsions partielles sont davantage coordonnées sous la prévalence génitale ; le cours la situe dans le développement psychosexuel et ses remaniements pubertaires.

CARTE 180

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Fixation » ?

> Réponse. Maintien privilégié d'un investissement ou d'un mode de satisfaction lié à un temps antérieur du développement, auquel une régression peut ensuite reconduire dans la lecture psychanalytique.

CARTE 181

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Angoisse » ?

> Réponse. Peur sans objet, ou sans objet clairement défini, traduisant dans le cours la détresse de l'appareil psychique face à des menaces internes et pouvant mobiliser ses défenses.

CARTE 182

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Signal d'angoisse » ?

> Réponse. Forme atténuée d'angoisse jouant un rôle d'alarme pour le Moi et déclenchant des opérations défensives dans la seconde théorie freudienne.

CARTE 183

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Angoisse automatique » ?

Réponse. Réaction de débordement face à un afflux d'excitations internes ou externes que le sujet ne peut maîtriser ; elle se distingue du signal d'alarme atténué.

CARTE 184

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Angoisses de morcellement » ?

Réponse. Angoisses massives et archaïques de destruction, d'anéantissement, d'annihilation, de dévoration, de mort psychique ou par éclatement, se traduisant par la sensation que le corps part en morceaux ou que l'identité vole en éclats.

CARTE 185

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Angoisses de perte d'objet » ?

Réponse. Angoisses liées à la séparation ou à la perte, réelle, anticipée ou fantasmatique, d'un objet d'amour.

À comprendre. Le cours les rapproche des angoisses d'abandon et de séparation, particulièrement décrites dans les états-limites.

CARTE 186

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Angoisses de castration » ?

Réponse. Angoisses de pertes symboliques touchant le sentiment de puissance ou de complétude et pouvant atteindre fantasmatiquement féminité, virilité, capacités intellectuelles ou physiques, autonomie et indépendance.

CARTE 187

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Relation d'objet » ?

Réponse. Manière dont un sujet investit ses objets et entre en relation avec eux, en fonction de son organisation et des modalités de son fonctionnement psychique.

CARTE 188

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Relation anaclitique » ?

Réponse. Relation dans laquelle le sujet s'appuie fortement sur un objet extérieur pour soutenir son équilibre et son Moi, avec une crainte importante de le perdre.

CARTE 189

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Structure psychique » ?

Réponse. Organisation relativement stable du fonctionnement de la personnalité dans la théorie psychanalytique, qui oriente les modalités de conflit, de défense et de décompensation.

CARTE 190

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Décompensation » ?

Réponse. Rupture d'un équilibre psychique antérieurement maintenu, avec apparition ou accentuation de manifestations psychopathologiques selon les fragilités de l'organisation.

CARTE 191

Dans la définition historique, que désigne la névrose ?

Réponse. Notion clinique et théorique historique désignant dans le support une maladie mentale dont le sujet reste douloureusement conscient. Elle peut entraîner des troubles durables de la personnalité, sans altérer profondément les fonctions essentielles. Le support la décrit comme fonctionnelle, sans lésion, et caractérisée par des conflits intrapsychiques, notamment dans l'hystérie, la névrose phobique et la névrose obsessionnelle.

CARTE 192

Dans la présentation historique de la névrose, quel rapport à la réalité et quelle limite de classement retenir ?

Réponse. L'oral insiste sur le maintien global du contact avec la réalité. Cette définition historique ne constitue pas l'équivalent d'une catégorie diagnostique contemporaine unique.

CARTE 193

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Psychose » ?

Réponse. Notion regroupant dans le cadre du cours des organisations et tableaux où le rapport à la réalité peut être profondément altéré ; elle ne se définit pas par un signe isolé.

CARTE 194

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « États-limites » ?

Réponse. Organisations décrites par Bergeret comme des astructurations entre les grandes structures, avec enjeux narcissiques, dépendance à l'objet et angoisses de perte ; ce modèle ne se confond pas automatiquement avec une catégorie du DSM.

CARTE 195

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Perversion » ?

> Réponse. Notion historique de la psychopathologie psychanalytique, distincte de l'usage courant d'insulte ; le cours insiste sur la coexistence de reconnaissance et de déni de la loi ou de la castration dans le clivage dit pervers.

CARTE 196

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Puberté et remaniement psychosexuel » ?

> Réponse. Dans le modèle du cours, poussée pulsionnelle et modifications corporelles s'accompagnent d'un remaniement identificatoire et d'une réactivation des enjeux œdipiens.

À comprendre. La capacité génitale donne une portée nouvelle aux fantasmes incestueux, contre lesquels le sujet se défend, et sollicite la prise de distance avec les objets parentaux au profit d'autres investissements.

CARTE 197

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Première théorie freudienne de l'angoisse » ?

> Réponse. Le refoulement produit l'angoisse : lorsque la pulsion ne peut être satisfaite, la représentation est refoulée et la charge ou quantum d'affect est transformé en angoisse.

À comprendre. C'est la première articulation causale exposée dans le support.

CARTE 198

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Seconde théorie freudienne de l'angoisse » ?

> Réponse. L'angoisse provoque les défenses, notamment le refoulement.

À comprendre. Un signal de déplaisir, reproduction atténuée d'une ancienne réaction traumatique, mobilise le Moi face aux exigences pulsionnelles ; la perte ou menace de perte de l'objet joue souvent un rôle. Ce signal se distingue du débordement de l'angoisse automatique.

CARTE 199

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Deuil et travail de deuil » ?

> Réponse. Réaction à la perte d'un objet d'amour et travail de remaniement psychique de cet investissement.

À comprendre. Dans l'exemple oral, le sujet reprend les traces de la relation et peut conserver un lien intérieur à l'objet par introjection. La souffrance n'est pas automatiquement pathologique ; contexte, intensité, durée et retentissement sont à examiner.

CARTE 200

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Stade du miroir » ?

> Réponse. Repère évoqué à l'oral pour penser la reconnaissance de sa propre image et la constitution d'un sentiment d'unité du corps et du Moi.

À comprendre. Il sert ici à comprendre le pôle identitaire, sans constituer un test diagnostique ni une explication suffisante d'une pathologie.

CARTE 201

Quels grands repères organisent le développement psychosexuel dans le modèle psychanalytique ?

> Réponse. Oralité : succion et incorporation ; analité : expulsion, rétention et maîtrise ; phallique et Œdipe : puissance, curiosité et triangulation ; latence : apprentissages et sublimations ; puberté : remaniements et nouveaux investissements.

À comprendre. Les âges sont indicatifs, les enjeux peuvent se chevaucher et persister ; un comportement isolé ne permet pas un diagnostic.

CARTE 202

Que distinguent auto-érotisme, narcissisme et amour d'objet ?

> Réponse. L'auto-érotisme trouve une satisfaction locale sur le corps propre ; le narcissisme investit le Moi unifié ; l'amour d'objet investit l'autre.

À comprendre. Le narcissisme a une fonction développementale et ne signifie pas automatiquement égoïsme ou trouble.

CARTE 203

Qu'est-ce qui distingue les trois grandes angoisses décrites ?

> Réponse. Morcellement : menace de destruction de l'unité corporelle ou identitaire ; perte d'objet : menace réelle, anticipée ou fantasmatique sur le lien d'amour ; castration : perte symbolique de puissance, de complétude ou de capacités.

À comprendre. La castration ne se réduit pas aux organes génitaux. Une angoisse de morcellement isolée, notamment en situation extrême, ne prouve pas une psychose.

CARTE 204

Comment distinguer les deux théories freudiennes de l'angoisse ?

> Réponse. Première : le refoulement et la non-satisfaction transforment la charge affective en angoisse. Seconde : l'angoisse-signal alerte le Moi et déclenche des opérations défensives.

À comprendre. Dans la seconde, le signal atténué se distingue de l'angoisse automatique liée au débordement.

CARTE 205

Comment accompagner une parole sur des violences ou mutilations sexuelles selon les repères de la fiche ?

> Réponse. Écouter le vécu et la demande, respecter le moment où la personne peut en parler et l'informer sur des consultations spécialisées adaptées, notamment pour évaluer les possibilités de reconstruction.

À comprendre. Une réponse chirurgicale ne résume pas les besoins psychiques, relationnels et traumatiques de la personne.

Chaque mécanisme de défense et la relation de soin

CARTE 206

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Mécanisme de défense » ?

> Réponse. Opération par laquelle le Moi se protège d'une menace ou d'un conflit susceptible de susciter une angoisse et d'atteindre l'intégrité psychique.

À comprendre. Ces opérations sont inconscientes dans la liste du cours, sauf la mise à l'écart volontaire.

CARTE 207

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Refoulement » ?

> Réponse. Opération inconsciente repoussant ou maintenant hors de la conscience des représentations conflictuelles qui restent actives.

À comprendre. Leur retour transformé peut participer au rêve, au lapsus ou au symptôme.

CARTE 208

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Retour du refoulé » ?

> Réponse. Réapparition indirecte et transformée de contenus maintenus dans l'inconscient, notamment lorsque le refoulement ne suffit plus à les contenir.

CARTE 209

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Déplacement » ?

> Réponse. Transfert de l'accent ou de l'intensité affective d'une représentation vers une autre, initialement moins importante, par des liens associatifs ; le conflit est ainsi déplacé vers un autre contenu.

CARTE 210

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Isolation » ?

> Réponse. Séparation d'une représentation et de l'affect qui lui est associé, ou déconnexion de pensées et conduites normalement liées ; le contenu peut rester conscient mais apparaître froid ou indifférent.

CARTE 211

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Annulation rétroactive » ?

Réponse. Tentative inconsciente de rendre non advenus une pensée, une parole ou un geste au moyen d'une autre pensée ou conduite de sens opposé ; elle relève d'une logique de pensée magique.

CARTE 212

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Formation réactionnelle » ?

Réponse. Adoption d'une attitude ou d'un trait opposé à un désir refoulé, souvent de façon rigide, forcée ou excessive ; le cours cite notamment une pudeur très accentuée contre une tendance exhibitionniste.

CARTE 213

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Dénégation » ?

Réponse. Refus de reconnaître comme sien un désir, une pensée ou un sentiment venant d'être formulé et jusque-là refoulé.

À comprendre. Le contenu atteint l'expression, mais le sujet en refuse l'appartenance.

CARTE 214

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Déni » ?

Réponse. Refus inconscient de reconnaître la réalité d'une perception vécue comme trop dangereuse, traumatisante ou douloureuse pour le Moi ; il ne se confond pas avec une contestation volontaire ni un simple doute.

CARTE 215

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Projection » ?

Réponse. Attribution au dehors, à une personne ou une chose, de pensées, affects, désirs ou qualités que le sujet méconnaît ou refuse de reconnaître en lui-même.

CARTE 216

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Clivage du Moi » ?

Réponse. Coexistence dans le Moi de deux attitudes psychiques contradictoires, par exemple reconnaissance et déni de la réalité, qui persistent sans s'influencer et sans compromis.

CARTE 217

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Clivage de l'objet » ?

Réponse. Séparation de l'objet en un pôle entièrement bon et un pôle entièrement mauvais, difficilement réunis dans une représentation ambivalente.

À comprendre. Le bon objet est gratifiant, idéalisé et recherché ; le mauvais est frustrant, dévalorisé et attaqué. L'oral décrit comment cette opposition peut être projetée sur différents membres d'une équipe.

CARTE 218

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Renversement en son contraire » ?

Réponse. Transformation du but pulsionnel en son contraire : activité en passivité, amour en haine, voyeurisme en exhibitionnisme, sadisme en masochisme ou inversement.

À comprendre. Il concerne l'orientation de la tendance et se distingue de la formation réactionnelle qui porte notamment sur une attitude ou un trait de caractère opposé au désir refoulé.

CARTE 219

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Retournement contre soi » ?

Réponse. Détournement vers soi d'une agressivité qui ne peut être reconnue ou adressée à l'objet extérieur ; le cours le relie notamment à la culpabilité et aux conduites autopunitives.

CARTE 220

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Introjection » ?

Réponse. Inclusion fantasmatique dans le psychisme d'un objet, d'une partie de l'objet ou du lien avec lui.

À comprendre. Elle permet notamment de garder intérieurement les traces d'une relation malgré l'absence ou la perte.

CARTE 221

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Identification » ?

Réponse. Assimilation inconsciente d'un aspect, d'une propriété ou d'un attribut d'autrui, conduisant le sujet à se transformer en partie ou en totalité sur ce modèle ; les identifications participent à la construction de la personnalité.

CARTE 222

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Identification à l'agresseur » ?

> Réponse. Forme d'identification où un sujet confronté à un danger extérieur s'identifie à son agresseur, soit en reprenant l'agression, soit en l'imitant physiquement ou moralement, soit en adoptant des symboles de puissance qui le caractérisent.

À comprendre. Ce processus défensif ne constitue ni un consentement à la violence ni un choix délibéré de la subir.

CARTE 223

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Idéalisation » ?

> Réponse. Élévation des qualités et de la valeur d'un objet à un degré de perfection, pouvant servir à se défendre contre la haine et l'ambivalence dans la lecture du cours.

CARTE 224

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Régression » ?

> Réponse. Retour plus ou moins organisé et transitoire à des modes antérieurs de pensée, de conduite ou de relation face à une angoisse ou une frustration ; elle peut apparaître dans la maladie.

CARTE 225

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Activisme » ?

> Réponse. Recours à l'action pour gérer un conflit ou une situation traumatique à la place de la réflexion et du vécu des affects ; l'agitation peut ainsi éviter de penser ce qui angoisse.

CARTE 226

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Rationalisation » ?

> Réponse. Justification apparemment logique mais artificielle de jugements, sentiments ou conduites, masquant à l'insu du sujet leurs motifs inconscients.

CARTE 227

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Intellectualisation » ?

> Réponse. Recours privilégié à l'abstraction et à la généralisation pour se tenir à distance d'une situation dont l'affect serait trop angoissant ; elle se distingue d'une recherche volontaire d'informations.

CARTE 228

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Sublimation » ?

> Réponse. Le support regroupe deux devenirs de la pulsion : d'une part, inhibition du but sexuel en conservant le même objet, avec transformation du désir en tendresse, amitié ou camaraderie ; d'autre part, dérivation de la libido vers des activités artistiques, intellectuelles ou morales socialement valorisées, avec changement de but ou d'objet et sans recours au refoulement.

À comprendre. Il faut distinguer ces deux descriptions et ne pas confondre sublimation et refoulement.

CARTE 229

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Humour » ?

> Réponse. Dans la liste des défenses, manière de présenter sa propre situation pénible ou traumatisante sous un angle plaisant, insolite ou ironique ; le cours insiste sur l'humour appliqué à soi.

CARTE 230

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Altruisme » ?

> Réponse. Dans son emploi défensif, dévouement à autrui permettant au sujet d'échapper à un conflit psychique ; ce sens ne résume pas toutes les motivations d'une aide.

CARTE 231

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Mise à l'écart » ?

> Réponse. Rejet volontaire, hors du champ actuel de la conscience, de problèmes, désirs, sentiments ou expériences qui tourmentent.

À comprendre. Le cours la distingue comme consciente, à la différence du refoulement.

CARTE 232

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Transfert » ?

> Réponse. Déplacement d'affects d'un objet du passé vers un objet du présent selon une analogie ou association le plus souvent inconsciente, réactualisant des attentes et modalités relationnelles antérieures.

CARTE 233

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Transfert positif / négatif » ?

> Réponse. Polarités affectives du transfert : attachement, confiance ou idéalisation d'une part ; hostilité, crainte ou rejet d'autre part.

À comprendre. Elles peuvent coexister et se modifier dans la relation.

CARTE 234

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Contre-transfert » ?

> Réponse. Réactions psychiques du soignant engagées dans la rencontre avec le patient et ses mouvements transférentiels ; leur repérage soutient la réflexion sur la relation.

À comprendre. Le terme est annoncé, sans développement détaillé, dans le support.

CARTE 235

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Résistance » ?

> Réponse. Dans le contexte psychanalytique, processus faisant obstacle à l'accès ou au travail de certains contenus psychiques ; le transfert peut servir de résistance tout en constituant un levier thérapeutique.

CARTE 236

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Clivage institutionnel » ?

> Réponse. Opposition entre groupes de professionnels pouvant prolonger dans l'équipe la division des objets en bons et mauvais vécue par le patient ; l'oral en fait un enjeu de réflexion collective.

CARTE 237

Dans le modèle psychanalytique, comment définir « Stratégies de coping » ?

> Réponse. Manières de faire face à une situation stressante.

À comprendre. L'oral distingue notamment la recherche volontaire d'informations pour réduire le stress de l'intellectualisation défensive, où la fonction d'éloignement de l'affect échappe au sujet.

CARTE 238

Comment distinguer refoulement et mise à l'écart ?

> Réponse. Le refoulement maintient inconsciemment une représentation hors de la conscience ; la mise à l'écart est une décision volontaire de différer une préoccupation.

À comprendre. Le refoulé reste actif : le refoulement n'est pas une destruction du souvenir.

CARTE 239

Quelle différence entre dénégation et déni ?

> Réponse. La dénégation laisse apparaître un contenu formulé tout en refusant de le reconnaître comme sien ; le déni porte sur la reconnaissance d'une réalité extérieure perçue.

À comprendre. Une simple négation verbale ou un doute ne suffisent pas à conclure à l'un de ces mécanismes.

CARTE 240

Comment distinguer isolation, intellectualisation et rationalisation ?

Réponse. Isolation : séparation entre représentation et affect ou entre pensées liées ; intellectualisation : recours à l'abstraction pour éloigner l'affect ; rationalisation : justification logique apparente masquant d'autres déterminants.

À comprendre. Une recherche volontaire d'informations peut être une stratégie de coping ; toute réflexion n'est pas une défense.

CARTE 241

Qu'est-ce qui distingue clivage du Moi et clivage de l'objet ?

Réponse. Le clivage du Moi maintient deux attitudes incompatibles sans compromis ; le clivage de l'objet sépare des aspects entièrement bons et entièrement mauvais.

À comprendre. Dans une équipe, reprendre cette opposition à son compte peut alimenter un clivage institutionnel.

CARTE 242

Comment répondre à une idéalisation d'un soignant et au rejet des autres ?

Réponse. Mettre en commun les observations, réfléchir aux réactions soignantes et maintenir un cadre cohérent, tout en examinant les plaintes et les difficultés réelles.

À comprendre. Une hypothèse transférentielle ou de clivage ne rend pas la parole du patient illégitime.

CARTE 243

Une défense suffit-elle à prouver une pathologie ou une structure ?

Réponse. Non. Les défenses existent chez tous ; leur fonction, leur rigidité, leur exclusivité, leur efficacité et leur adéquation à la réalité doivent être appréciées dans l'ensemble du fonctionnement.

À comprendre. Les affinités théoriques entre défenses et organisations ne sont pas une règle diagnostique fondée sur un signe isolé.

Sémiologie, diagnostics et classifications

CARTE 244

Comment définir « Sémiologie psychiatrique » ?

Réponse. Étude et recueil des manifestations psychiques, en distinguant symptômes rapportés, signes observables et syndromes ; le terme séméiologie est aussi employé.

CARTE 245

En sémiologie, comment définir le symptôme et le distinguer du signe ?

Réponse. Au sens sémiologique précis, manifestation subjective d'un processus pathologique, ressentie ou décrite par le patient, à distinguer du signe clinique observé.

CARTE 246

Quels sens plus larges le symptôme peut-il prendre dans la rencontre clinique et la lecture psychanalytique ?

Réponse. Dans l'abord de la rencontre clinique, le support l'emploie aussi au sens plus large de signal d'alerte : changement émotionnel, cognitif ou comportemental tranchant avec le fonctionnement habituel, parfois repéré d'abord par l'entourage. Dans la lecture psychanalytique, certains symptômes sont compris comme formations de compromis entre désir et défense, dotées d'un sens et d'une fonction pour le sujet.

CARTE 247

Comment définir « Signe clinique » ?

Réponse. Manifestation repérable par l'observation du clinicien, à distinguer du vécu subjectif rapporté ; son interprétation dépend du contexte et de son association à d'autres manifestations.

CARTE 248

Comment définir « Syndrome » ?

Réponse. Association de signes et symptômes formant un ensemble clinique plus ou moins spécifique, susceptible d'orienter vers des hypothèses diagnostiques.

CARTE 249

Comment définir « Signifiant / signifié » ?

Réponse. Dans la présentation sémiologique du support, le signifiant est la forme matérielle d'un signe ; le signifié est son contenu ou sa signification.

CARTE 250

Comment définir « Nosographie » ?

Réponse. Description et organisation des maladies ou troubles en ensembles permettant leur classement et leur communication clinique.

CARTE 251

Comment définir « Nosologie » ?

Réponse. Étude et organisation conceptuelle des maladies, de leurs catégories et de leurs relations ; l'oral la rattache notamment à la réflexion sur leurs causes.

CARTE 252

Comment définir « Recueil sémiologique » ?

Réponse. Étape de collecte et de discrimination de ce que le patient décrit et de ce qui est observé, avant l'élaboration du diagnostic.

CARTE 253

Comment définir « Diagnostic » ?

Réponse. Démarche et conclusion consistant à reconnaître un trouble à partir d'un ensemble de manifestations, de leur organisation, de leur contexte et de critères pertinents.

CARTE 254

Comment définir « Hypothèse étiopathogénique » ?

Réponse. Proposition concernant les causes et mécanismes par lesquels un trouble s'est constitué et se maintient ; elle doit être distinguée d'un fait directement observé.

CARTE 255

Comment définir « Diagnostic différentiel » ?

Réponse. Raisonnement distinguant plusieurs causes ou troubles susceptibles d'expliquer des manifestations proches, notamment une autre affection médicale ou l'effet d'une substance.

CARTE 256

Comment définir « Bénéfice primaire » ?

Réponse. Dans le modèle psychanalytique, apaisement de l'angoisse ou diminution de l'intensité d'un conflit interne rendu possible par la formation du symptôme.

CARTE 257

Comment définir « Bénéfice secondaire » ?

Réponse. Avantage conscient ou inconscient qu'un sujet peut tirer de sa pathologie psychique ou somatique ou de ses conséquences.

À comprendre. Il est distinct de l'apaisement interne du conflit, appelé bénéfice primaire. Sa présence ne prouve pas une simulation ni l'absence de souffrance.

CARTE 258

Comment définir « Symptôme labile » ?

Réponse. Manifestation changeante ou susceptible de se modifier rapidement ; le cours insiste sur cette labilité chez l'enfant en développement.

CARTE 259

Comment définir « Classification » ?

Réponse. Mise en ordre de phénomènes dans un système de classes partageant des caractéristiques ; elle remplit des fonctions de systématisation et d'aide au diagnostic.

CARTE 260

Comment définir « Systématisation » ?

Réponse. Organisation ordonnée d'une multiplicité de manifestations afin de pouvoir les décrire, les comparer et les penser plus facilement.

CARTE 261

Comment définir « Classification catégorielle » ?

Réponse. Classement reposant sur la présence ou l'absence de critères permettant l'inclusion dans une catégorie définie.

CARTE 262

Comment définir « Classification dimensionnelle » ?

Réponse. Évaluation de l'intensité ou de la fréquence d'une ou plusieurs dimensions, sans que leur mesure constitue automatiquement un diagnostic catégoriel.

CARTE 263

Comment définir « Classification typologique » ?

Réponse. Description des troubles par types ou configurations de traits associés à des syndromes.

À comprendre. L'appartenance repose sur certains traits essentiels, sans exiger tous les traits possibles. Le profil peut être établi à partir de l'observation et de l'expérience cliniques, éventuellement standardisées, ou par des méthodes statistiques ; il associe caractéristiques et intensité.

CARTE 264

Comment définir « Validité externe » ?

Réponse. Adéquation de la classification avec la réalité clinique qu'elle cherche à représenter dans la présentation du cours.

CARTE 265

Comment définir « Validité interne / cohérence » ?

Réponse. Cohérence des règles et des catégories du système permettant un raisonnement non contradictoire ; elle n'interdit pas l'existence de troubles associés.

CARTE 266

Comment définir « Fidélité temporelle » ?

Réponse. Stabilité du résultat lorsqu'une même situation clinique inchangée est évaluée à différents moments avec le même système.

CARTE 267

Comment définir « Fidélité inter-juges » ?

Réponse. Accord entre plusieurs évaluateurs utilisant le même système à partir d'une même situation clinique.

CARTE 268

Comment définir « Sensibilité » ?

Réponse. Capacité de repérage des situations qui relèvent du trouble recherché ; le support l'évoque plus largement avec la capacité de différenciation des tableaux et de leurs évolutions.

CARTE 269

Comment définir « Faux négatif » ?

Réponse. Situation où un trouble présent n'est pas repéré par la démarche de classification ou d'évaluation utilisée.

CARTE 270

Comment définir « Faux positif » ?

Réponse. Situation où l'évaluation conclut à un trouble alors qu'il n'est pas présent dans les conditions recherchées.

CARTE 271

Comment définir « Comorbidité » ?

Réponse. Présence associée de plusieurs troubles chez une même personne ; elle justifie de rechercher ce qui accompagne ou reste masqué derrière la plainte principale.

CARTE 272

Comment définir « Épisode dépressif caractérisé · EDC » ?

Réponse. Ensemble d'au moins cinq des neuf manifestations décrites dans l'exemple du support, sur une même période d'au moins deux semaines, avec humeur dépressive ou perte d'intérêt/plaisir, changement et retentissement significatifs ; les exclusions doivent aussi être examinées.

CARTE 273

Comment définir « Anhédonie » ?

Réponse. Diminution ou perte de la capacité à éprouver de l'intérêt ou du plaisir pour les activités habituellement investies ; elle constitue un des deux symptômes centraux de l'exemple d'EDC.

CARTE 274

Comment définir « Ralentissement psychomoteur » ?

Réponse. Diminution observable de l'activité motrice et du rythme psychique ; dans l'exemple diagnostique, il ne se limite pas au seul ressenti intérieur de lenteur.

CARTE 275

Comment définir « Hypersomnie / insomnie » ?

Réponse. Augmentation excessive du sommeil d'une part ; difficulté de sommeil d'autre part.

À comprendre. Elles font partie des manifestations à considérer dans l'exemple dépressif, sans être spécifiques à elles seules.

CARTE 276

Comment définir « Manie / hypomanie » ?

Réponse. États d'élévation ou d'irritabilité de l'humeur et d'activation, d'intensité et de retentissement différents.

À comprendre. Le support les cite surtout comme antécédents à rechercher pour distinguer le trouble dépressif unipolaire d'un trouble bipolaire ; leurs critères complets ne sont pas détaillés ici.

CARTE 277

Comment définir « Rémission partielle » ?

Réponse. Amélioration d'un trouble avec persistance de certaines manifestations ou de critères résiduels ; elle se distingue de la rémission complète.

CARTE 278

Comment définir « Rémission complète » ?

Réponse. Disparition des manifestations définissant l'épisode considéré ; elle ne signifie pas automatiquement disparition de toute vulnérabilité ou arrêt d'un suivi.

CARTE 279

Comment définir « Rechute » ?

Réponse. Réapparition ou aggravation d'un trouble après une amélioration ; elle doit être appréciée dans l'évolution clinique.

CARTE 280

Comment définir « Diagnostic provisoire » ?

Réponse. Hypothèse diagnostique retenue en attente d'informations ou d'une observation évolutive suffisantes, plutôt qu'une conclusion présentée comme définitive.

CARTE 281

Comment définir « Diagnostic non spécifié » ?

Réponse. Catégorie employée lorsqu'un tableau répond aux critères généraux d'une classe sans satisfaire ceux d'un trouble spécifique, ou lorsqu'un regroupement non inclus dans la classification provoque une souffrance ou une déficience significative.

À comprendre. Le support cite aussi l'étiologie incertaine et des informations manquantes, incohérentes ou contradictoires. Ce terme ne signifie ni absence de trouble ni certitude sur sa cause.

CARTE 282

Comment définir « Diagnostic de rétablissement » ?

Réponse. Évaluation des perspectives d'amélioration et de retour à une vie ordinaire en fonction des ressources et possibilités de la personne, en complément du nom du trouble.

CARTE 283

Comment définir « DSM » ?

Réponse. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'American Psychiatric Association ; le cours présente le DSM-5 comme descriptif et principalement catégoriel, avec critères et spécifications de sévérité et d'évolution.

CARTE 284

Comment définir « CIM » ?

Réponse. Classification internationale des maladies portée par l'Organisation mondiale de la santé, couvrant maladies et problèmes de santé ; le support compare sa démarche clinique à celle du DSM.

CARTE 285

Comment définir « CFTMEA » ?

Réponse. Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, soulignant des repères développementaux, dynamiques et structuraux, ainsi que des dimensions catégorielles et dimensionnelles.

CARTE 286

Comment définir « APA / OMS » ?

Réponse. APA : American Psychiatric Association, organisme éditant le DSM.

À comprendre. OMS : Organisation mondiale de la santé, responsable de la CIM dans la présentation du cours.

CARTE 287

Comment définir « Mortalité / morbidité » ?

Réponse. La mortalité concerne les décès dans une population ; la morbidité concerne la présence ou la fréquence des maladies.

À comprendre. Le cours les relie à l'histoire et aux usages de la CIM.

CARTE 288

Comment définir « Modèle processuel » ?

Réponse. Modèle centré sur les processus psychiques participant à la dynamique des troubles, plutôt que seulement sur leur classement en catégories.

CARTE 289

Comment définir « Processus transdiagnostique » ?

Réponse. Mécanisme susceptible d'intervenir dans plusieurs troubles ou catégories diagnostiques ; son étude peut relier des tableaux différents.

CARTE 290

Comment définir « Modèle en réseau de symptômes » ?

Réponse. Modèle expliquant un trouble par des relations complexes et des interactions entre symptômes, sans supposer nécessairement une cause morbide sous-jacente unique.

CARTE 291

Comment définir « Névroses actuelles / de transfert » ?

Réponse. Distinction historique freudienne : les premières sont rapportées à des facteurs actuels ; les secondes sont abordées à partir de conflits et de leur réactualisation transférentielle.

À comprendre. Ces groupes ne sont pas des équivalents directs des diagnostics contemporains.

CARTE 292

Comment définir « Névrose d'angoisse » ?

Réponse. Catégorie historique de névrose actuelle centrée sur des manifestations anxieuses ; les rapprochements proposés à l'oral avec les troubles anxieux sont des repères, pas une équivalence nosographique exacte.

CARTE 293

Comment définir « Neurasthénie » ?

Réponse. Catégorie historique citée parmi les névroses actuelles, associant notamment fatigue et plaintes nerveuses ; ses critères ne sont pas développés dans ce support.

CARTE 294

Comment définir « Hypocondrie » ?

Réponse. Préoccupation anxieuse concernant la santé et la possibilité d'être malade, citée dans la classification historique ; cette mention ne suffit pas à définir tous les critères d'un diagnostic contemporain.

CARTE 295

Comment définir « Névrose obsessionnelle » ?

Réponse. Catégorie historique marquée par des pensées contraignantes, conflits et défenses notamment d'isolation et d'annulation ; elle ne se superpose pas automatiquement à tout trouble obsessionnel-compulsif.

CARTE 296

Comment définir « Névrose phobique » ?

Réponse. Catégorie historique où une crainte est attachée à un objet ou une situation et peut conduire à l'évitement ; elle est aussi appelée hystérie d'angoisse dans la classification présentée.

CARTE 297

Comment définir « Schizophrénie » ?

Réponse. Trouble cité dans les psychoses et rattaché à la dissociation dans la tradition française du cours ; l'oral insiste sur la désorganisation de la pensée et des associations, et non sur une double personnalité.

À comprendre. Le support n'en expose pas tous les critères diagnostiques.

CARTE 298

Comment définir « Paranoïa / psychose paranoïaque » ?

Réponse. Notions historiques de psychose non dissociative du tableau français, associées dans l'oral à un délire et à une lecture projective ; leurs critères complets ne sont pas exposés dans ce cours introductif.

CARTE 299

Comment définir « Mélancolie / manie et PMD » ?

Réponse. Termes de la classification historique regroupés sous psychose maniaco-dépressive.

À comprendre. L'oral rapproche la PMD des troubles bipolaires et décrit la mélancolie comme une dépression particulièrement grave ; ce rapprochement ne remplace pas les critères diagnostiques.

CARTE 300

Comment définir « Bouffée délirante aiguë · BDA » ?

Réponse. Terme de la tradition française désignant un tableau psychotique aigu, d'apparition rapide, dont l'évolution doit être observée.

À comprendre. Un épisode isolé ne permet pas de conclure d'emblée à une évolution chronique.

CARTE 301

Comment définir « Dissociation psychiatrique » ?

Réponse. Dans la tradition française présentée, désorganisation des liens entre pensée, affect et comportement, illustrée surtout à l'oral par la rupture des associations.

À comprendre. Elle ne signifie pas une double personnalité.

CARTE 302

Comment définir « Barrage » ?

Réponse. Interruption brusque du cours de la pensée ou du discours, illustrée à l'oral comme une manifestation de la désorganisation des associations.

CARTE 303

Comment définir « Fading » ?

Réponse. Effacement ou ralentissement progressif du cours de la pensée et du discours, distingué à l'oral du caractère abrupt du barrage.

CARTE 304

Comment définir « Psychose hallucinatoire chronique · PHC » ?

Réponse. Catégorie historique française de psychose chronique non dissociative où les phénomènes hallucinatoires et l'automatisme mental occupent une place importante dans la présentation orale.

CARTE 305

Comment définir « Automatisme mental » ?

Réponse. Ensemble de phénomènes vécus comme imposés ou échappant à la maîtrise du sujet, notamment autour de la pensée ; il est évoqué à l'oral à propos de la PHC sans description exhaustive.

CARTE 306

Comment définir « Paraphrénies » ?

Réponse. Catégories historiques de psychoses chroniques non dissociatives, évoquées à l'oral par des productions délirantes imaginatives et fantastiques ; leurs critères ne sont pas détaillés dans le support.

CARTE 307

Comment définir « Impulsion / compulsion » ?

Réponse. L'oral distingue une tendance impérieuse au passage à l'acte, pouvant court-circuiter la pensée, d'une conduite contraignante contre laquelle le sujet peut lutter anxieusement.

À comprendre. Ces termes ne sont pas synonymes de pulsion.

CARTE 308

Comment définir « Athéorique » ?

Réponse. Dans la présentation du DSM, intention de ne pas faire dépendre la description diagnostique d'une théorie causale particulière et de privilégier les critères cliniques et les données empiriques.

À comprendre. L'oral rappelle que la construction d'une classification comporte néanmoins des choix.

CARTE 309

Comment définir « Sévérité légère, moyenne ou sévère » ?

Réponse. Spécification de l'intensité d'un trouble.

À comprendre. Le support décrit un niveau léger avec peu de symptômes au-delà du minimum requis et une altération mineure du fonctionnement ; un niveau sévère avec davantage de symptômes, des manifestations particulièrement intenses ou un retentissement marqué ; le niveau moyen est intermédiaire.

CARTE 310

Comment définir « Antécédent / diagnostic principal » ?

Réponse. Un antécédent est un événement ou trouble de l'histoire clinique utile à l'évaluation actuelle.

À comprendre. Le diagnostic principal désigne le trouble retenu comme principal dans la situation de consultation ; les troubles associés ne disparaissent pas pour autant. Le motif exprimé de consultation et le diagnostic principal sont à distinguer.

CARTE 311

Comment définir « Transcodage » ?

Réponse. Mise en correspondance des codes de plusieurs classifications, notamment CFTMEA et CIM dans le support, pour faciliter les échanges, recherches et usages administratifs.

À comprendre. Une correspondance de code n'implique pas une identité parfaite des concepts.

CARTE 312

Comment distinguer symptôme, signe et syndrome ?

Réponse. Le symptôme désigne notamment le vécu subjectif rapporté ; le signe est observé ou objectivé ; le syndrome regroupe des manifestations associées.

À comprendre. Un syndrome ne donne pas à lui seul une cause unique ; le recueil précède l'hypothèse diagnostique.

CARTE 313

Quels bénéfices primaire et secondaire un symptôme peut-il avoir dans la lecture psychanalytique ?

Réponse. Primaire : apaisement interne du conflit ou de l'angoisse ; secondaire : avantages liés aux conséquences du trouble, conscients ou inconscients.

À comprendre. Un avantage ne démontre pas que le symptôme est volontairement fabriqué.

CARTE 314

Pourquoi contextualiser particulièrement les manifestations de l'enfant ?

Réponse. Le développement, l'âge, la relation et l'environnement modifient leur sens ; les symptômes peuvent être labiles. Une souffrance peu bruyante peut être importante.

À comprendre. Éviter les étiquettes figées ne signifie pas retarder systématiquement l'aide : le repérage précoce garde son intérêt.

CARTE 315

Quelles différences entre classement catégoriel, dimensionnel et typologique ?

Réponse. Catégoriel : inclusion selon des critères ; dimensionnel : intensité ou fréquence de dimensions ; typologique : profil organisé autour de traits essentiels.

À comprendre. Les approches peuvent se combiner ; une mesure isolée ne constitue pas un diagnostic.

CARTE 316

Pourquoi fidélité et validité ne sont-elles pas synonymes ?

Réponse. La fidélité concerne notamment la stabilité à situation inchangée et l'accord des évaluateurs ; la validité concerne la pertinence de la représentation ou du classement.

À comprendre. Plusieurs évaluateurs peuvent être d'accord sans que la catégorie soit valide. La cohérence n'exclut pas les comorbidités.

CARTE 317

Quelles conditions symptomatiques d'ensemble sont nécessaires pour un épisode dépressif caractérisé ?

> Réponse. Au moins cinq symptômes parmi neuf, sur une même période d'au moins deux semaines, avec changement par rapport au fonctionnement antérieur et au moins une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir.

À comprendre. Le nombre seul ne suffit pas : il faut aussi apprécier retentissement, exclusions et histoire clinique.

CARTE 318

Quels sont les neuf domaines symptomatiques d'un épisode dépressif caractérisé ?

> Réponse. Humeur dépressive ; intérêt ou plaisir ; poids ou appétit ; sommeil ; psychomotricité ; énergie ; valeur de soi ou culpabilité ; pensée, concentration ou décision ; pensées de mort ou idées et conduites suicidaires.

À comprendre. Les neuf domaines ne sont pas tous obligatoires ; le seuil est d'au moins cinq, avec l'un des deux premiers et les autres conditions.

CARTE 319

Quelles précisions concernent l'humeur dépressive dans les critères d'EDC ?

> Réponse. Elle est présente pratiquement toute la journée, presque tous les jours, rapportée par la personne ou observée par autrui ; chez l'enfant et l'adolescent, elle peut être irritable.

À comprendre. Une tristesse isolée ne fournit ni la durée ni l'ensemble des critères de l'épisode.

CARTE 320

Quelles précisions concernent la diminution d'intérêt ou de plaisir dans l'EDC ?

> Réponse. Elle est marquée pour toutes ou presque toutes les activités, pratiquement toute la journée et presque tous les jours, rapportée ou observée.

À comprendre. Avec l'humeur dépressive, elle constitue l'un des deux domaines centraux : au moins l'un des deux est requis.

CARTE 321

Que recouvre le domaine poids ou appétit dans l'EDC ?

> Réponse. Une perte ou un gain significatif hors régime, par exemple plus de 5 % en un mois, ou une diminution ou augmentation de l'appétit presque tous les jours. Chez l'enfant, considérer l'absence de prise de poids attendue.

À comprendre. Une perte de poids n'est donc pas obligatoire chez toute personne présentant un épisode dépressif.

CARTE 322

Quelles modifications du sommeil et de l'énergie figurent dans les critères d'EDC ?

> Réponse. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours ; fatigue ou perte d'énergie presque tous les jours.

À comprendre. Sommeil et énergie constituent deux domaines distincts du décompte.

CARTE 323

Quelle condition concerne l'agitation ou le ralentissement psychomoteur de l'EDC ?

> Réponse. Ils sont présents presque tous les jours et observables par autrui, au-delà du seul sentiment intérieur de fébrilité ou de lenteur.

À comprendre. Le vécu subjectif seul ne satisfait pas cette précision du critère psychomoteur.

CARTE 324

Quelles précisions concernent la culpabilité et les difficultés cognitives de l'EDC ?

> Réponse. Dévalorisation ou culpabilité excessive ou inappropriée, parfois délirante, presque tous les jours ; diminution de l'aptitude à penser ou se concentrer, ou indécision, presque tous les jours, rapportée ou observée.

À comprendre. La culpabilité ne se limite pas au reproche ordinaire d'être malade. Valeur de soi et cognition constituent deux domaines distincts.

CARTE 325

Que recouvre le domaine mort ou suicide dans les critères d'EDC ?

> Réponse. Des pensées de mort récurrentes ne se limitant pas à la peur de mourir, des idées suicidaires récurrentes, une tentative ou un projet suicidaire selon la situation.

À comprendre. L'absence de projet précis ou une apparence calme ne suffisent pas à écarter la souffrance ni le besoin d'évaluation.

CARTE 326

Quels éléments examiner au-delà du décompte des symptômes dépressifs ?

> Réponse. La souffrance cliniquement significative ou l'altération du fonctionnement, l'attribution éventuelle à une substance ou une affection médicale, le contexte d'une perte et l'histoire des épisodes thymiques.

À comprendre. Un deuil ne confirme ni n'exclut automatiquement un épisode dépressif.

CARTE 327

Pourquoi distinguer épisode dépressif et trouble dépressif unipolaire ?

Réponse. Un épisode dépressif peut survenir dans un trouble bipolaire. Le classement unipolaire implique notamment de vérifier l'absence d'antécédent maniaque ou hypomaniaque et que l'épisode n'est pas mieux expliqué par certains troubles psychotiques.

À comprendre. Un antécédent maniaque ne rend pas impossible la survenue d'un épisode dépressif ; il modifie le classement global du trouble.

CARTE 328

Quels organismes portent le DSM et la CIM, et quel est leur périmètre ?

Réponse. Le DSM est porté par l'Association américaine de psychiatrie et concerne les troubles mentaux ; la CIM relève de l'OMS et couvre l'ensemble des maladies et problèmes de santé.

À comprendre. La CFTMEA concerne l'enfant et l'adolescent ; une correspondance de codage ne rend pas les modèles identiques.

CARTE 329

Comment distinguer rémission et guérison définitive ?

Réponse. La rémission décrit l'amélioration ou la disparition des manifestations de l'épisode ; elle peut être partielle ou complète et exister sous traitement.

À comprendre. Elle n'implique pas automatiquement disparition de toute vulnérabilité, arrêt du suivi ou arrêt du traitement.

CARTE 330

Dans le classement français historique, comment se répartissent les psychoses citées ?

Réponse. Formes aiguës : bouffée délirante aiguë. Formes chroniques dissociatives : schizophrénie. Formes chroniques non dissociatives : paranoïa, psychose hallucinatoire chronique et paraphrénies.

À comprendre. Une bouffée délirante aiguë peut rester isolée, récidiver ou s'inscrire dans une évolution chronique ; la dissociation psychiatrique ne signifie pas double personnalité.

CARTE 331

Comment distinguer barrage et fading ?

Réponse. Le barrage interrompt brusquement le cours de la pensée ou du discours ; le fading correspond à un effacement ou ralentissement progressif.

À comprendre. Un silence isolé ne permet pas de diagnostiquer une schizophrénie.

Vocabulaire clinique rencontré dans les exemples

CARTE 332

Comment définir « Hallucination » ?

Réponse. Expérience perceptive vécue en l'absence d'un objet extérieur correspondant, évoquée notamment dans les exemples de voix ; sa signification doit être appréciée dans son contexte et ne définit pas seule un diagnostic.

CARTE 333

Comment définir « Délire » ?

Réponse. Ensemble de convictions et d'interprétations marquant une altération du rapport à la réalité dans les tableaux psychotiques cités ; le contenu seul ne suffit pas à caractériser tout le fonctionnement d'une personne.

CARTE 334

Comment définir « Dépersonnalisation » ?

Réponse. Expérience d'étrangeté concernant soi-même ou son identité, évoquée à l'oral pour illustrer le sentiment de ne plus se reconnaître ou de perdre son unité.

CARTE 335

Comment définir « Reviviscence traumatique » ?

Réponse. Retour vécu comme actuel d'éléments d'une expérience traumatique, cité à l'oral avec les cauchemars ; le souvenir pénible peut s'imposer plutôt qu'être volontairement recherché.

CARTE 336

Comment définir « Passage à l'acte » ?

Réponse. Recours à une action pouvant court-circuiter l'élaboration et l'expression psychiques d'un conflit ou d'un affect dans la lecture orale du cours ; les causes d'un acte ne se réduisent pas à cette seule hypothèse.

CARTE 337

Comment définir « Anesthésie psychique » ?

Réponse. Sensation de ne plus éprouver d'émotions ou de se sentir intérieurement vide, décrite dans un exemple oral de souffrance dépressive très importante.

CARTE 338

Comment définir « Angoisse de dévoration » ?

Réponse. Forme d'angoisse archaïque où le sujet redoute d'être absorbé ou détruit par l'objet ; elle figure dans la définition orale des angoisses de morcellement.

CARTE 339

Comment définir « Astasie-abasie » ?

Réponse. Incapacité à se tenir debout et à marcher, illustrée dans le cas historique d'Élisabeth ; le terme décrit une difficulté et ne démontre pas, à lui seul, sa cause.

CARTE 340

Comment définir « Aphonie » ?

Réponse. Perte de la voix ; elle fait partie des manifestations corporelles citées dans l'histoire de l'hystérie, sans que toute aphonie soit psychogène.

CARTE 341

Comment définir « Aphasie » ?

Réponse. Trouble du langage affectant son expression ou sa compréhension ; elle est citée dans le récit d'Anna O. et dans les repères historiques sur Freud, sans fournir ici une classification neurologique.

CARTE 342

Comment définir « Mutisme » ?

Réponse. Absence de parole dans une situation donnée ; il est cité parmi les manifestations historiques et demande une analyse de son contexte et de ses causes.

CARTE 343

Comment définir « Parésie / paralysie » ?

Réponse. La parésie désigne une diminution de la force motrice ; la paralysie une perte du mouvement volontaire.

À comprendre. Leur présence ne permet pas d'en déduire automatiquement une origine psychique.

CARTE 344

Comment définir « Anesthésie corporelle » ?

Réponse. Perte ou diminution de sensibilité dans un territoire, citée parmi les symptômes historiques ; elle se distingue de l'anesthésie psychique qui concerne le ressenti affectif.

CARTE 345

Comment définir « Algies / céphalées » ?

Réponse. Algies : douleurs ; céphalées : douleurs de la tête.

À comprendre. Le support les mentionne parmi des expressions corporelles possibles, sans que ces termes déterminent leur étiologie.

CARTE 346

Comment définir « Vaginisme » ?

Réponse. Contraction involontaire de la musculature à l'entrée du vagin rendant la pénétration difficile ou impossible ; le terme est cité dans la liste historique des manifestations corporelles, sans développement thérapeutique dans ce support.

CARTE 347

Comment définir « Psyché-soma » ?

Réponse. Expression soulignant les liens entre vie psychique et corps, notamment chez le jeune enfant dont les difficultés peuvent s'exprimer par des manifestations corporelles.

CARTE 348

Comment définir « Énurésie » ?

Réponse. Émission involontaire d'urine, évoquée à l'oral comme une manifestation possible chez l'enfant ; l'âge, le développement, le contexte et les causes doivent être pris en compte avant d'en interpréter le sens.

CARTE 349

Comment définir « Égodystonique / égosyntonique » ?

Réponse. Un vécu égodystonique est ressenti comme étranger ou en désaccord avec soi ; un vécu égosyntonique est en accord avec soi.

À comprendre. Ces mots décrivent le rapport subjectif à un vécu et ne suffisent pas à conclure à une pathologie.

CARTE 350

Comment définir « Morbidité / indice morbide » ?

Réponse. Le premier terme renvoie aux maladies dans une population ; l'emploi de « morbide » dans la définition du champ renvoie à ce qui concerne la maladie, sans constituer à lui seul un critère diagnostique.